



קבוצה	אנטי־פיברינוליטי
מנגנון הפעולה	הקסקפרון הוא נגזרת סינטטית של חומצת אמינו ליזין והוא משמש למניעה ולטיפול בדימומים (בזמן ניתוח, כתוצאה מטרומבה, דימום ספונטני). הקסקפרון מעכב את ההפיכה של פלסמינוגן לפלסמין. הפלסמין אחראי על פירוק פיברין – אחד המרכיבים העיקריים בקריש הדם.
פרמקוקינטיקה	תחילת השפעה מיידית. משך ההשפעה 3 שעות. זמן מחצית חיים שעותיים.
התוויות לשימוש	מתן ב־I.V. – דימום משמעותי בטרומבה עם שני סימנים נוספים לפחות – חיורון והזעה; לחץ דם סיסטולי נמוך מ־90 mmHg; דופק מעל 110 במדידות חוזרות; מילוי קפילרי איטי; ירידה במצב ההכרה. – דימום מסיבי שלא כתוצאה מטרומבה (כגון דרכי עיכול, וגינלי) אשר אינו ניתן לעצירה ומלווה בסימנים לירידה בפרפוזיה. מתן מקומי דימום משמעותי מריריות (אפיסטקסיס, דימום מהחניכיים).
התוויות נגד	רגישות ידועה לתרופה.
תופעות לוואי	כאבי ראש; כאבי גב; כאבי בטן; בעיות בסינוסים הנזליים.
מינון	מתן ב־I.V. מבוגרים – 1 gr מהול ב־100 ml סליין, בטפטוף במשך 10 דקות, בזמן הפינוי. לחלופין – מתן ב־PUSH איטי במשך כמה דקות. ילדים – 15 mg/kg (מנה מקסימלית 1 gr = 2 אמפולות) מהולים ב־50 ml סליין, בטפטוף במשך 10 דקות, בזמן הפינוי. לחלופין – מתן ב־PUSH איטי במשך כמה דקות. מתן מקומי הספגת תוכן של אמפולה אחת בפד גזה ולחיצה על נקודת הדימום.
צורות מתן במד"א	I.V. שימוש מקומי
מופיע בפרוטוקול	<u>הטיפול בנפגע טראומה; סיבוכים בלידה</u>